



認知症と間違えやすい 高齢者のてんかん

『ぼーっとするだけ』のことがあります

監修: 今村久司 (てんかん学会専門医・指導医)

こんな様子に心当たりは?



会話中に急に止まり、一点を見つめてぼーっとする



声をかけても数十秒～数分、反応がない



口をもぐもぐ・手をもぞもぞ動かす



我に返った後、その間のことを覚えていない

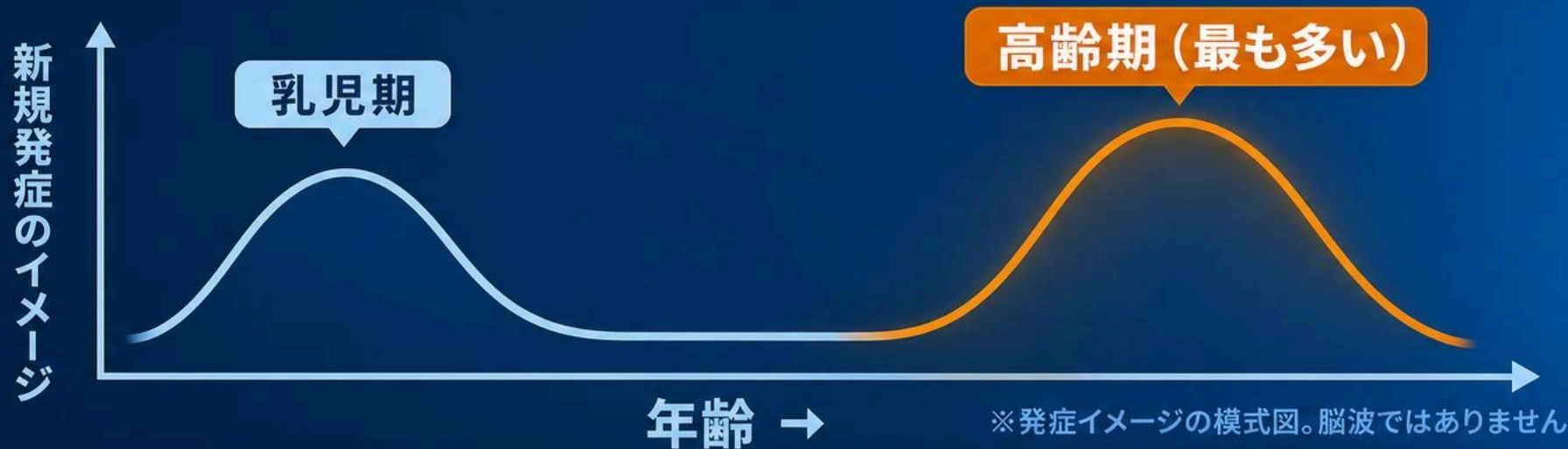


同じ様子が何度も繰り返し起こる



『認知症が始まった?』 → 実は『てんかん』かもしれません

実は 高齢者に最も多い



『子どもの病気』というイメージは**誤解**

世界で**7,000万人以上**が抱える、ありふれた脳の病気

『ぼーっとするだけ』の発作

焦点意識減損発作



数十秒～数分

しょうてん いしき げんそん ほっさ

脳の一部から始まり、
意識が部分的に途切れる発作



突然始まり、
突然終わる

全身けいれんの『大発作』はむしろ少ない

だから本人も周りも気づきにくい

こんな症状が出ます

1 凝視



一点を見つめて
動きが止まる

2 もうろう状態



ぼんやり・
受け答えがちぐはぐ

3 自動症



口をもぐもぐ・
舌なめずり・
手をもぞもぞ

4 発作後の遷延



高齢者は
もうろうが長引きやすい

5 健忘



その間の記憶が
ぽっかり抜ける

なぜ認知症と間違われる？



見逃しの理由

- 1 | けいれんしない + 短時間 + 『もの忘れ』に見える
- 2 | 本人は覚えておらず、目撃者がないと病歴がとりにくい

認知症との見分け方

見るポイント	てんかん	認知症
起こり方	発作性（突然・短時間）	持続的・進行性
パターン	毎回似ている（常同的）	全般的に少しずつ低下
記憶	その間だけ抜ける（健忘の島）	全体的に物忘れが進む
合間	終われば元どおり	ずっと続く



『発作性かどうか』が最大の手がかり

TIA・失神との見分け方

見るポイント	てんかん	TIA・失神
 症状の質	動きが加わる (自動症など陽性症状)	TIAは脱力・しびれ・ ろれつ困難(脱落症状)
 反復のしかた	毎回同じパターンで繰り返す	TIAは出方がさまざま
 回復	発作後もうろうが遷延 (高齢者で長引く)	失神は前ぶれ後 すぐ回復

 **いずれも自己判断は禁物 → 受診して検査を**

原因は脳の傷

脳血管障害



脳梗塞・脳出血
(最も多い)

神経変性



アルツハイマー病
など

腫瘍・外傷



脳腫瘍・過去の
頭部のけが

前ぶれのことも



将来の脳卒中・
認知症の入口



放置せず、一度きちんと調べる意味がある

診断はどうする？

1

問診（最重要）



いつ・どのくらい・
常同性・反復・短時間が
カギ

2

目撃情報・動画



家族の観察や
スマホ動画が役立つ

3

脳波（のうは）



てんかん性の波を探す
（1回で必ず出るとは
限らない）

4

頭部MRI



脳梗塞・腫瘍など
原因を調べる



本人は覚えていないことが多い。**周りの観察**が診断のカギ

治療と予後 よく効きます



気づけば治せる



抗てんかん薬が
よく効く



副作用・飲み合わせの
少ない薬を少量から



多くは発作を抑えられ、
予後は良好

こんなときは受診を



予約受診

脳神経内科・てんかん専門外来

- ✓ 会話中に急にぼーっと止まる／一点凝視が繰り返す
- ✓ 短時間の健忘が繰り返す
- ✓ 認知症と言われたが『発作的』に出る



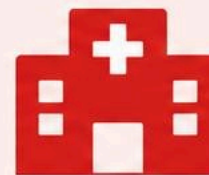
受診先

脳神経内科・
てんかん専門外来



すぐ救急 119 番

- ❗ 発作が5分以上続く／発作後30分以上意識が戻らない
- ❗ 初めてのけいれん／頭部打撲後の発作
- ❗ 麻痺・ろれつ困難・顔のゆがみ／高熱・激しい頭痛・首の硬さ



受診先

救急外来



準備：発作の様子をメモ・動画で記録して持参

まとめ3つのポイント

1



てんかんは高齢者に最も多く、
『ぼーっとする』けいれんしない発作として現れる

2



認知症と間違われやすいが、
発作性・短時間・常同的・健忘の谷間で見分けられる。
そして治療できる

3



気づいたら脳神経内科・てんかん専門外来へ。
よく効く病気

『ぼーっと』を見逃さないで

気づけば、 治せる

『**ぼーっと**』を見逃さないで



チャンネル登録・高評価をお願いします



監修：今村久司（神経内科専門医・指導医／てんかん学会専門医・指導医）



医知創造ラボ | その症状大丈夫？ #23